**جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *** **طلب علاج أول مرة / متردد**

**إسم المريض رباعياً :** ناديه محمد على حسين
**المحافظة :** القاهره **الحي / المدينة :** البساتين **العنوان :** *********
**رقم البطاقة :** 28803110103523 **رقم التليفون :** 01140942426 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
**العمر(تاريخ الميلاد) :** 11-03-1988 **المهنة :** ربه منزل

## الإقرار

**أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك**

**الإخصائي الاجتماعي** **المقر بما فيه**
**التوقيع:**(----------) **التوقيع:**(----------)

**التشخيص الإكلينيكي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**نتائج الأبحاث :** (مرفق)
**التشخيص النهائي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**خطة العلاج :** أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
**التعليق على التشخيص :** ----------

## تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

**الاسم:** د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

**أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.**
**كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.**

**تعتمد صحة البيانات المرفقة**
**رئيس اللجنة و مدير المستشفي.**

**تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.**

## أعضاء اللجنة

**ا.د/** ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

## قرار اللجنة

**التشخيص النهائي :** ----------
**خطة العلاج :** ----------
**المستشفي :** ----------**قسم :** ----------
**جهة العلاج :** ----------**نفقات :** ----------
**ملاحظات :** ----------

| رئيس | مدير عام | ختم |
|---|---|---|
| المجلس الطبي المتخصص | مديرية الشئون الصحية | شعار الجمهورية |

Name: ناديه محمد علي حسين
National ID: 28803110103523

## تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

| | |
|---|---|
| إيماء للطلب المقدم من | بشأن تقرير طبي للمريض |
| بقسم: | رقم طبي: |

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

| | |
|---|---|
| تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd | تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026 |

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

| | |
|---|---|
| التاريخ : 05-07-2026 | الوقت : -- --:-- |
| | الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين |

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



ناديه

محمد على حسين

٨ ش الشوادفى-فايده كامل

البساتين - القاهره

١٩٨٨/٠١/٢١

٢٨٨٠٣١١٠١٠٣٥٢٣

JJ7626137

٢٨٨٠٣١١٠١٠٣٥٢٣ ٢٠٢٢/٠٥

حاصلة على دبلوم تجارة

انثى مسلمة متزوجة

محمد على فؤاد على عبداللطيف

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٥/١٨

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

# MDT form

A-Patient ID:
1- Name : نغوية محمد علي حسين
Sex: Female
3- Medical number: 83145835
Old Med : 2087-2023
2-ID number: 28803110103523
Patient Age : 36 Y

MDT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family history | Family History | Phone | Phone 01140942426 | BMI | BMI 36 | REASON OF MDT | REASON OF MDT REMDT |
| marital status | Marital Status | NRS Score | NRS Score 2 | GROUP | GROUP B | Date of MDT | Date of MDT 20/01/2024 |
| Co morbidity | Co Morbidity free | Menopausal status | Menopausal Status PREMENOPAUSAL | Initial STAGE | Initial STAGE | | |

## Clinical data

**Breast Imaging :**

**Mets Workup :**
bone scan : equivocal lt distal femor
MRI lt femor distal lesion 8 x3.5x2.5 cm

| BX | ER | PR | Her 2 Neu | SISH | Ki67 |
|---|---|---|---|---|---|
| IDC<br>BX COMMENT: | 8/8<br>ER COMMENT: | 8/8<br>PR COMMENT: | 2<br>Her 2 Neu COMMENT: | SISH COMMENT : | 50 |

| T | N | M |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |

**Sonomammography**

**PATIENT HISTORY**
she has locally advanced breast and suspicious lt femorral lesion was sent to bone biopsy but now ortho need complete excision of the mass (bone mass)
pet ct:free
llast MDT 5/12/2023:BEING THE BONY LESION WAS DIAGNOSED BY MRI NOT PET CT ... FOR NEW MRI MEANWHILE CONTINUE AI+ HERCEPTIN THEN REMDT ( PRIMARY OR MET BONY LESION)
AFTER MRI FOR WIRE BRAKETTING BY 4 WIRES AND NIPPLE EXCISION (CENTRAL QUADRANTECTOMY AND TARGET US AXILLA ACC

## MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN
FOR ADJUVANT HERCEPTIN UP TO 1 YEAR (RECIEVED ONLY 2 IV HERCEPTIN NEOADJUVANT)
PORT
AI+ ZOLADEX
REVIEW THE PATHOLOGY OF FEMORAL LESION TO ENSURE DURATION OF IV HERCEPTIN

## SIGNATURE

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDICAL ONCOLOGY | MEDICAL ONCOLOGY د/ شريف صادق | RADIOLOGY | RADIOLOGY د/ |
| SURGERY | SURGERY د/ | PATHOLOGY | PATHOLOGY |
| Psychiatric | Psychiatric | Nutrition | Nutrition اسراء حربي |

| | |
|---|---|
| **Name:** نادية محمد علي | |
| **MR. :** 7808 | |

Detailed Medical Report

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | | **بشأن تقرير طبي للمريض** | |
| **بقسم:** | | **رقم طبي:** | |

**ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** | | **تاريخ وساعة الخروج :** | |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها**

**The patient presented for initiation of Femara therapy, with supportive treatment for three months of BSM <, PAUS >>>R. The patient has a lesion at the left femur, for which a bone marrow biopsy was performed, yielding cores of clotted blood. A bone scan was also obtained, and the results were reported as R.**

**The patient returned for a second dose of Zoldex Femara, with the last ultrasound performed two months prior. On physical examination, mild lymphedema was noted in the right arm.**

**The patient was prescribed letrazol 2.5 mg, calcium, and one alfa 1 m for a duration of two months, scheduled for 5-6/2026.**

**تحريرا في ,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **التاريخ :** | 21-09-2026 | **الوقت :** | |

**الطبيب المعالج :** محمد رضا أبو اليزيد كيلاني

**يعتمد ,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patient Name | : الأستاذه / ناديه محمد على حسين | Request No. | : 13004803 |
| Patient No. | : 28803110103523 | Request Date | : 27/12/2023 |
| Path No. | : 4589/23 | Verification Date | : 09/01/2024 |
| Sex | : Female | Financial Category | : اورام دار السلام - نفقة الدولة |
| Age | : 35 Y | Department | : Out Patient |
| Referreing Doc | : | Registered by | : .marwa mohamed youss |

## Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer post NACT
Nature of the specimen : Left BCS & Left ALND .

Gross Examination:
Two specimens were received :
- Left BCS specimen measured 11x10 cm , including nipple & areola. Cut section revealed wired area:
wired fairly defined greyish white firm tumour bed site measured
1 x1 cm , .
- Axilla measured 10x8 cm enclosing 12 SLNs
- Extra lateral margin: Fibrofatty tissue piece; 4x3 cm. grossly unremarkable.
• Frozen section: Suspicious lateral margin for DCIS & Free SLNs (0/5)

Microscopic examination:
• Histological type: Invasive duct carcinoma, GII
Tumor cellularity 15% . Actual tumor size; 0.9x0.9 cm.
• 10% DCIS
• Angioinvasion: yes
• Lymph node involvement: Positive (2/12) , with extra-capsular extension.
• Resection Margins: Free Extra-lateral margin & Free other margins.
• Histologic response to therapy: Pathologic partial response
• Additional pathological findings: Fibrosis & hyalinosis (Effect of therapy)

Diagnosis:
Left Breast, PNAC, Left Conservative Surgery & left ALND :
• Remnants of Invasive duct carcinom, GII.
• Free resection margins
• Positive LNs (2/12)

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud



غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patient Name | : الأستاذه / ناديه محمد على حسين | Request No. | : 13004803 |
| Patient No. | : 28803110103523 | Request Date | : 27/12/2023 |
| Path No. | : 4589/23 | Verification Date | : 09/01/2024 |
| Sex | : Female | Financial Category | : اورام دار السلام - نفقة الدولة |
| Age | : 35 Y | Department | : Out Patient |
| Referreing Doc : | | Registered by | : .marwa mohamed youss |

## Pathology Report

- Pathologic Partial response
- Stage : ypT1b, ypN1
- Residual Cancer Burden: 3.19
  Residual Cancer Burden Class: II.

Signature

Prof. Gamal Abdelaty

Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud



CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

*Fatth Islamic Center*

C.T. - M.R.I

U.S. - Duppler - E.C.G. Stress

E.E.G - E.M.G - Mamm - Eye Unit

الجمعية الشرعية

مركز الفتح الإسلامى

أشعة مقطعية بالكمبيوتر - الرنين المغناطيسى
موجات صوتية - دوبلر ملون - رسم قلب بالمجهود
رسم مخ - رسم عضلات - فحص ثدى - وحدة عيون

اسم المريض : ناديه محمد علي التاريخ : ٢٠٢٤/١٠/٥

# MSCT REPORT

Multislice CT scan examination was done for the **Chest**, Abdomen and Pelvis

Multiplanner reconstruction images were obtained following I.V. and oral contrast enhancement

*Compared to the previous study dated 17-3-2024 the current study revealed:*

***I – Chest:***

- *Left upper lobe anterior and lingular segment ground glass veiling as well as thin fibro-atelectatic bands likely post radiotherapy effect.*
- *Thin atelactatic band along middle lung lobe*
- *Clear both lung fields with no evidence of focal pulmonary infiltration or masses.*
- *No evidence of pleural or pericardial sac collection*
- *No hilar or mediastinal lymph nodes enlargement.*
- *Normal C.T. appearance of the heart and its great vessels.*

***II - Abdomen & pelvis:***

- *Mildly enlarged hepatic size, showing uniform low parenchyma and regular outlines (fatty infiltration), with no definite focal lesions or intrahepatic biliary duct dilatation.*
- *The spleen, gall bladder, both kidneys (apart from left small benign looking exophytic lesion considered as angiomyolipoma is also noted), adrenal glands and pancreas are within normal limits, with no obvious mass lesion or significant lymph node enlargement.*
- *The opacified bowel loops including the stomach are regularly filled, with no obvious mass lesion or significant mural thickening.*
- *No intra-pelvic mass lesions or lymphadenopathy detected.*
- *No ascites or pelvic collections seen.*
- *IUD is seen in situ*
- *Normal C.T. appearance of the uterus, adnexa, urinary bladder and distal bowel loops.*
- *Clinical correlation would be recommended guided by the operative data pathological result and treatment protocol.*

*YOURS SINCERELY,*
*Prof. Dr. Mohammed Fouad,*
*PROF. OF RADIO-DIAGNOSIS*
*EL-AZHAR UNIVERSITY*

٨١ شارع ١٠ بالمعادى ت : ٢٣٥٨٧٣٣٢ - ٢٣٥٨٥٨١٩ - ٠١١٠٠١٥١٣٨٠ - ٠١٠٢٨٤٨٣٦٩٥

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

| | |
|---|---|
| Patient Name: Nadia Mohamed Ali Hussein | Date : 14/12/2023 |
| Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE ) | Age : 35 Year(s) |
| Medical ID: 2087/2023 | |

## Targeted ultrasound on bilateral axillae

**Indication:**

- Patient with pathologically proven left breast carcinoma.

**Report:**

- Left single pathological axillary lymph node at level I showing focal cortical thickening reaching 6 mm.
- Right axillary non-specific lymph nodes.
- Free bilateral supra and infra clavicular regions.

Best regards,

Dr. Asmaa Zeinhom, Msc

Not Approved

Presidential Program for Women's health

Name: Nadia Moahmed Ali

Date:11-5-2023

Bilateral Full field Digital Mammography

Technique

Mediolateral oblique and CC views

High resolution ultrasound

Detailed Findings

right breast

- Scattered fibroglandular mammary parenchyma (ACR B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesion .
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs .

left breast

- Scattered fibroglandular mammary parenchyma (ACR B).
- Upper outer & retro areolar asymmetrical density , distortion and suspicious groups of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated UOQ and retro areolar parenchymal distortion and an area of mixed echogenicity , micro calcification with evidence of ductal extension
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- pathological axillary LNs at level I (2LN) largest is measuring 15.3X10mm ( eccentric hilum and diffuse cortical thickness measuring 5mm ) .

Conclusion:

-right breast: (BIRADS 2 ) adenosis

-left breast: (BIRADS 4C ) UOQ and retro areolar asymmetrical density and pathological micro calcification and ipsilateral pathological LN for biopsy

Dr. shaden mahmoud

١٠٥٣ ش كورنيش النيل . فم الخليج القاهرة جمهورية مصر العربية.
ت/ف - ٠٢٢٣٦٤٥٨١٣
البريد الإلكتروني info@whop.gov.eg

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and
Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

***Exam Information:***

| | |
|---|---|
| ***Patient Name:*** *NDEA Muhammed* | ***Date of birth:*** *11/03/1988* |
| ***Arabic Name:*** نادية محمد | ***Patient Gender:*** *F* |
| ***Patient RIS ID:*** *333719*<br>***Patient HIS ID:*** *123015980* | ***Exam Date:*** *10/08/2023* |
| **Written by:**<br>Dr. Hoda Fathy | **Approved by:**<br>Dr. Hoda Fathy |

## $^{99m}$Tc MDP Bone Scan Report (07/08/2023)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of $^{99m}$Tc MDP

**Revealed:**

- Active focal well-defined osseous lesion is noted overlying the Lt distal femoral shaft of equivocal nature, for further clinico-radiological correlation.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

## Conclusion:

Equivocal active Lt distal femoral osseous focal lesion as described, for further clinico-radiological correlation.

**Much Obliged**

Mayadah Ashraf

Rawan Mohammed

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

| | |
|---|---|
| Patient Name: Nadia Mohamed Ali Hussein | Date : 01/02/2024 |
| Exam : C.T CHEST | Age : 36 Year(s) |
| Medical ID: 2087/2023 | Pat. ID: 40838<br>Total DLP (mGy.cm) : 727.20 |

## ***NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -***

### ***Findings:***

- Clear both lung fields
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

### ***OPINION:***

- ***Essentially normal CT study of the chest.***

*Dr. Amr Farouk, M.D.*